



FUNDACIÓN PELO A PELO

Pelo a Pelo

¿Qué dice tu pelo sobre ti?

Jessica Lagno Assael

Psicóloga · Fundadora de Pelo a Pelo

«Aquí no estás sola.»



ÍNDICE

Contenido

PRÓLOGO El día que me miré sin pelo

01 Lo que el pelo le dice a la ciencia

02 El médico y el espejo roto

03 No es vanidad, es identidad

04 Veinte años de paciencia involuntaria

05 El pelo y el tiempo

06 El silencio como herramienta

07 Cuando perdemos algo, el pelo nos avisa

08 La mirada de los otros

09 Aceptación no es resignación

10 De la herida a la comunidad

EPÍLOGO Lo que el pelo me enseñó



PRÓLOGO

El día que me miré sin pelo

Los procesos que de verdad importan son lentos. Eso es lo primero que aprendí en este camino, y lo aprendí a la fuerza.

Hoy parece que todo nos pide resultados rápidos: una crema para que crezca el pelo, una respuesta que cierre la herida, una solución que nos saque del problema antes de entenderlo. Pero el cuerpo no funciona así. Tiene su propio ritmo, y casi siempre es más lento de lo que queremos. El pelo crece un centímetro al mes. La confianza tarda aún más. Y la comunidad, ese grupo de personas que se apoyan, se construye poco a poco. Pelo a pelo.

Si estás leyendo esto porque tu pelo empezó a caer, quiero decirte algo importante. Ese síntoma no es solo una urgencia que hay que ocultar; también es una señal. Y la invitación no es a salir corriendo, sino a detenerte.

Deténte para escuchar lo que tu cuerpo te dice. Para volver a sus ritmos naturales, esos que hemos aprendido a ignorar por vivir siempre apuradas. Para preguntarte qué estabas viviendo cuando empezó la caída. Y, sobre todo, para no quedarte sola en ese momento del camino.

Hay procesos que no se pueden vivir en soledad, y sanar es uno de ellos. Por eso este libro no termina aquí; es la puerta de entrada a algo que se construye entre muchas personas, poco a poco, en comunidad.

La primera vez fue a los cinco años. No recuerdo exactamente qué vi en el espejo, porque los niños todavía no saben ponerle palabras a lo que les asusta, pero sí recuerdo la cara de mi madre. Recuerdo que algo cambió en su expresión de una forma que yo no podía nombrar,

pero sí sentir. El mundo, que hasta ese momento había sido predecible, se movió un poco. Y eso bastó para que algo en mí empezara a ver las cosas de otra manera. La segunda vez fue a los veintiocho años. Para entonces ya tenía las palabras y la historia. También tenía la ilusión, que me duró trece años, de que eso había quedado atrás. Cuando el pelo empezó a caer otra vez, no solo se fue el pelo. También se fue una versión de mí misma que creía ser fuerte.

Durante veinte años, desde los cinco hasta los quince y luego de los veintiocho a los treinta y ocho, la alopecia fue una compañera que no elegí. A veces era silenciosa, a veces muy dura. Siempre estaba presente de alguna forma, incluso en los años en que el pelo volvió.

Este libro no es un manual de tratamientos. No promete que el pelo vuelva. No ofrece recetas. En cambio, es una invitación a hacer una pregunta que el sistema médico rara vez plantea y que, sin embargo, lo cambia todo:

¿Qué estabas perdiendo tú cuando empezaste a perder el pelo?

El pelo no se cae sin motivo. Se cae mientras estamos viviendo algo. Entender qué era eso, con compasión, sin culpas y con honestidad, es el comienzo de un camino de regreso a una misma que ninguna crema puede ofrecer.

Este libro es mío, pero la historia que sigue no quiero escribirla sola. Quiero escribirla contigo y con cada persona que ha pasado por esto. La invitación es a crear, todas juntas, una historia diferente: una en la que nadie tenga que vivir la alopecia en soledad.

Si algo de lo que lees aquí te resuena, escíbeme. De verdad. Puedes contactarme en jessica.lagno@peloapelo.cl. No hay testimonio demasiado pequeño ni pregunta fuera de lugar. Cada voz suma al tejido que estamos creando juntas.

|

Bienvenida a Pelo a Pelo.



CAPÍTULO

01

Lo que el pelo le dice a la ciencia

Antes de hablar de lo que se pierde cuando cae el pelo, vale la pena entender qué es el pelo. No como adorno. Como sistema.

1.1 · El folículo piloso: mucho más que una raíz

Cada hebra de cabello nace de una estructura llamada folículo piloso, un órgano minúsculo pero extraordinariamente complejo que se encuentra en la dermis, la capa media de la piel. No es un simple agujero: es una unidad funcional que involucra células madre, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, glándulas sebáceas y señales hormonales.

El cabello crece aproximadamente un centímetro al mes y tiene su propio ciclo de vida con tres fases:

- **Fase anágena (crecimiento):** dura entre 2 y 7 años. El 85-90% del cabello se encuentra en esta fase en un momento dado.
- **Fase catágena (transición):** dura 2-3 semanas. El folículo se encoge y detiene la producción.
- **Fase telógena (reposo y caída):** dura 3-4 meses. El cabello cae y el folículo descansa antes de reiniciar el ciclo.

Perder entre 50 y 100 cabellos al día es completamente normal. Lo que no es normal y a veces ocurre es que el cuerpo interrumpa el ciclo de golpe o que el sistema inmune ataque los propios folículos.

1.2 · El pelo como biomarcador

Los médicos forenses, los toxicólogos y los endocrinólogos lo saben desde hace décadas: el pelo guarda historia. Un análisis de cabello puede revelar niveles de cortisol de los últimos meses, exposición a metales pesados, deficiencias nutricionales, desequilibrios hormonales. El pelo es literalmente un archivo del cuerpo.

Cuando ese archivo se interrumpe y el pelo cae, algo le muestra al mundo exterior que, por dentro, hubo una crisis. No siempre es grave. No siempre se ve. Pero es real.

1.3 · La alopecia areata: cuando el cuerpo se confunde de enemigo

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune. Esto significa que el sistema inmune, que está hecho para protegernos, ataca por error los folículos pilosos y los trata como si fueran una amenaza extraña.

No se entiende del todo por qué sucede. Hay factores genéticos: tener familiares con alopecia areata o con otras enfermedades autoinmunes (como tiroiditis de Hashimoto o diabetes tipo 1) aumenta el riesgo. Pero la genética no es destino: el gen necesita un disparador.

Y ese disparador, que la ciencia ya no puede ignorar por lo frecuente que es, suele tener un nombre emocional: estrés constante, duelos no resueltos, traumas o pérdida de seguridad.

Si el pelo habla tanto de lo que pasa adentro, ¿por qué el mundo médico solo trata lo de afuera?



CAPÍTULO

02

El médico y el espejo roto

La escena es conocida por quienes han vivido la alopecia. Entrás al consultorio. El dermatólogo examina tu cuero cabelludo con una lupa. Hace anotaciones. Te dice el nombre de lo que tienes —alopecia areata, efluvio telógeno, alopecia androgénica— y a continuación, escribe una receta: corticoides intralesionales, minoxidil tópico y, tal vez, un suplemento.

Te vas con el papel en la mano. Y nadie te ha preguntado cómo estás.

2.1 · El protocolo que trata la superficie

Los tratamientos médicos disponibles para la alopecia han avanzado significativamente en los últimos años. Los inhibidores de JAK, aprobados recientemente para casos graves, han mostrado resultados que antes parecían imposibles. El minoxidil cuenta con décadas de evidencia. Los corticoides actúan como antiinflamatorios locales.

Nada de esto está mal. El problema no es lo que hace el sistema médico. El problema es lo que no hace.

2.2 · Lo que la consulta de 30 minutos no puede contener

La consulta promedio de dermatología en el sistema público de salud latinoamericano dura entre 10 y 30 minutos. En ese tiempo, el médico debe revisar, diagnosticar, recetar y documentar. No hay espacio real para preguntar:

- ¿Qué estaba viviendo cuando empezó esto?
- ¿Cómo está afectando esto tu vida cotidiana?
- ¿Tienes apoyo emocional para atravesar este proceso?

Y sin esas preguntas, el tratamiento aborda el síntoma. No a la persona.

2.3 · La fragmentación que enferma más

La alopecia, como muchas enfermedades autoinmunes, se sitúa en la intersección de la dermatología, la endocrinología, la inmunología y la psicología. Pero el sistema de salud opera en silos. El dermatólogo trata la piel. El endocrinólogo, las hormonas. El psicólogo, si es que alguien llega al psicólogo, trabaja la mente. Rara vez se hablan entre sí.

Y la persona con alopecia queda en medio de ese vacío, tratando de armar sola un rompecabezas cuyas piezas están repartidas entre distintos consultorios.

2.4 · Lo que la evidencia dice que falta

Múltiples estudios sobre la calidad de vida en personas con alopecia documentan lo que cualquier persona que la ha vivido ya sabe: la pérdida del pelo genera niveles de ansiedad y depresión comparables a los de enfermedades consideradas «graves» por el sistema médico. Un estudio publicado en el *Journal of the American Academy of Dermatology* encontró que el 74% de los pacientes con alopecia areata reportaron un impacto significativo en su calidad de vida. El 39% presentaba criterios clínicos de depresión.

Sin embargo, el derivamiento a salud mental sigue siendo la excepción, no la regla.

Perder el pelo no es una enfermedad de la piel. Es una experiencia de vida. Y el sistema médico aún no lo ha entendido del todo.



CAPÍTULO

03

No es vanidad, es identidad

Cuando alguien que nunca ha perdido el pelo escucha a otra persona llorar por eso, a veces piensa, aunque no lo diga, que es exagerado. Que es vanidad. Que hay cosas peores. No lo dicen con maldad. Lo dicen porque no saben lo que realmente se está perdiendo.

3.1 · El pelo no es decoración: es identidad encarnada

Desde las primeras semanas de vida, el cerebro humano construye una representación interna del propio cuerpo: el esquema corporal. Esta representación no es solo física —saber dónde están las manos—, sino también profundamente simbólica. Incluye cómo nos vemos, cómo creemos que nos ven, qué nos hace reconocibles para nosotros mismos y para los demás.

El pelo es uno de los elementos más importantes de ese esquema. No porque sea lo más importante para el cuerpo, sino porque es lo más visible, lo más significativo en la cultura y lo que más cambiamos a propósito. Es de las pocas partes del cuerpo que modificamos para mostrar quiénes somos, en qué etapa de la vida estamos, a qué grupo pertenecemos o cómo nos sentimos.

Cuando se cae sin que lo hayamos elegido, no se cae solo un conjunto de hebras. Se cae una parte del lenguaje con el que nos comunicamos con el mundo.

3.2 · La diferencia entre vergüenza y culpa

La investigadora Brené Brown propone una distinción que ilumina mucho de lo que viven las personas con alopecia:

La culpa dice: «Hice algo malo». La vergüenza dice: «Soy algo malo».

La culpa es específica y, aunque incómoda, tiene salida: puedes corregir lo que hiciste. La vergüenza es identitaria: no tiene acción correctiva porque, en la narrativa de la vergüenza, el problema eres tú misma.

La alopecia, sobre todo cuando aparece en la infancia o adolescencia, suele crear una historia de vergüenza. No porque alguien lo diga en voz alta, sino porque el cuerpo que se ve diferente, en un mundo que valora la uniformidad, aprende la lección: hay algo en mí que no debería ser así.

3.3 · La infancia sin pelo y la adultez sin pelo: dos dolores distintos

Perder el pelo a los cinco años es perderlo antes de haber formado bien la identidad. La pregunta no es «¿quién era yo antes de esto?», porque no hay un antes claro. La pregunta es más silenciosa y dura más: «¿Soy diferente de los demás? ¿Y eso está bien?»

Perder el pelo a los veintiocho es perderlo después de haber construido una identidad que lo incluía. La pregunta es otra: «¿sigo siendo yo sin esto?» Y hay una pérdida adicional: la de la ilusión de control sobre el propio cuerpo.

Ninguno de los dos dolores es menor. Son simplemente distintos. Y ambos necesitan ser nombrados, no minimizados.

Nadie llora por estética. Se llora por quien creía ser.



CAPÍTULO

04

Veinte años de paciencia involuntaria

Voy a contarte mi historia. No toda, porque la vida tiene muchas capas que no caben en un libro, pero sí la parte que importa para entender de dónde viene todo lo que sigue.

4.1 · Los cinco a los quince: la niña que no entendía

La primera vez que me cayó el pelo, yo tenía cinco años. No recuerdo el momento exacto, pero sí la sensación de que algo había cambiado en la manera en que la gente me miraba. Mi madre, que es una mujer de enorme fortaleza, empezó una carrera silenciosa de médicos, consultas y tratamientos. Yo la acompañé sin entender bien qué buscábamos.

En el colegio, fue más difícil. Los niños no tienen filtros ni vocabulario para el dolor ajeno. Hubo preguntas. Hubo miradas. Hubo días con peluca y otros sin ella. Hubo una versión de mí misma que aprendió muy temprano a gestionar la incomodidad ajena con su propio cuerpo.

A los quince, el pelo volvió. No de golpe: fue un proceso lento, casi tímido. Y yo aprendí a no fijarme demasiado para no volver a perderlo.

4.2 · El intervalo: los trece años de olvido

Desde los quince hasta los veintiocho, el pelo estuvo. No perfecto, no siempre igual, pero presente. Y en esa presencia, construí lo que construimos todos en esos años: una identidad, una profesión, relaciones, una manera de moverme por el mundo.

Lo que no hice y lo entendí después fue procesar la primera vez. La guardé, como se guardan las cosas que duelen demasiado para mirarlas de frente.

4.3 · De los veintiocho a los treinta y ocho: la recaída adulta

Cuando el pelo empezó a caer de nuevo, a los veintiocho, ya tenía las palabras. Ya sabía qué era la alopecia areata. Ya tenía herramientas profesionales, como la de psicóloga, que, en teoría, deberían haberlo hecho más fácil.

No lo hicieron más fácil. Lo hicieron más complejo. Porque sabía demasiado como para negarme a ver lo que estaba pasando, pero seguía teniendo el mismo dolor de siempre. El dolor de sentir el cuerpo fuera de control. El dolor de volver a ser la niña que mira a los demás y se pregunta si está bien.

Esos diez años también fueron los que más trabajé en mí misma. Psicoterapia, trabajo corporal, prácticas de silencio. Y paradójicamente, los años en que más entendí que la alopecia no había sido mi enemiga. Había sido, a su manera cruel, una maestra.

4.4 · La paciencia que no elegí

Veinte años con alopecia te enseñan paciencia a la fuerza. No es la paciencia tranquila de quien decide esperar, sino la de quien no tiene otra opción que seguir viviendo mientras el cuerpo hace lo suyo.

Pero hay algo que aprendí sobre esa paciencia: cuando se vuelve algo consciente, cuando dejas de solo soportarla y empiezas a vivirla, se transforma en otra cosa. En confianza. En la capacidad de estar con lo incierto sin romperse.

Eso no lo enseñan en ningún colegio. Y vale más de lo que puede calcularse.

|

*No elegí la alopecia. Sí elegí qué hacer
con ella.*



CAPÍTULO

05

El pelo y el tiempo

Vivimos en una cultura que ha declarado la guerra al tiempo. Queremos resultados ahora. Respuestas ahora. Cuerpos que sanen ahora.

El pelo no entiende de esa guerra. Tiene su propio ritmo y no se apura por la urgencia.

5.1 · La biología de la espera

El ciclo del cabello dura entre dos y siete años en su fase de crecimiento. Esto significa que cualquier tratamiento para la alopecia tarda meses en mostrar resultados visibles. Las células que responden a un medicamento hoy no producirán cabello visible hasta dentro de tres, cuatro o seis meses.

Para alguien que vive en la inmediatez digital, donde todo tiene respuesta en segundos, esa espera resulta casi incomprensible. Pero así funciona el cuerpo. No hay atajos.

5.2 · La psicología de esperar sin saber cuánto

La investigación en psicología del estrés ha identificado algo revelador: no es la espera lo que más daña. Es la incertidumbre sobre cuánto durará.

Saber que algo malo terminará en seis meses es tolerable. No saber si terminará —o cuándo— activa de manera sostenida el sistema de alerta, lo que agota los recursos del sistema nervioso.

Las personas con alopecia pertenecen a esa segunda categoría. No hay fecha. No hay garantía. El pelo puede volver, puede no volver, o puede volver y caerse de nuevo. Esa incertidumbre crónica tiene un costo psicológico real y documentado.

5.3 · Paciencia activa vs. resignación pasiva

Hay una distinción que quiero hacer con cuidado, porque se confunden con frecuencia:

- **Resignación** es decir: «esto es así, no hay nada que hacer, me resigno».
- **Paciencia activa** es decir: «esto está pasando, no puedo controlar el resultado, y aun así voy a cuidarme, buscar apoyo y vivir plenamente mientras espero».

La resignación paraliza. La paciencia activa construye. Y construir, incluso mientras el cuerpo hace lo suyo y sin saber cómo terminará, es lo que permite tener una vida plena con alopecia. No después de la alopecia, sino con ella.

Tu pelo lleva su propio ritmo. El trabajo consiste en aprender a vivir a ese ritmo.



CAPÍTULO

06

El silencio como herramienta

Hay un momento en el proceso de la alopecia que casi nadie menciona: cuando dejas de buscar la crema, el especialista, el suplemento o la respuesta afuera y simplemente te quedas quieta.

No porque te hayas rendido. Sino porque algo, muy adentro, te dice que la respuesta no estaba donde la estabas buscando.

6.1 · El ruido que hacemos cuando tenemos miedo

Cuando perdemos el pelo, nos volvemos hiperactivas hacia afuera. Buscamos diagnósticos, opiniones, soluciones, foros, testimonios, tratamientos. Llenamos el tiempo de movimiento porque detenerse significaría sentir lo que no queremos sentir.

Es un mecanismo completamente humano y comprensible. Pero hay un costo: mientras buscamos afuera, el cuerpo sigue hablando adentro y nadie lo escucha.

La ciencia tiene un nombre para esto: regulación emocional evitativa. No es debilidad. Es la estrategia que adopta el sistema nervioso cuando el dolor emocional supera los recursos disponibles para procesarlo. El problema es que evitar no resuelve. Solo pospone y, a veces, amplifica.

6.2 · Lo que el silencio revela que el ruido oculta

El silencio no es ausencia. Es un estado activo. Cuando nos detenemos de verdad, empiezan a aparecer preguntas diferentes:

- ¿Cuándo empezó esto realmente?
- ¿Qué estaba viviendo yo en ese momento?
- ¿Qué estaba sintiendo que no me permitía sentir?
- ¿A quién o qué le estoy respondiendo con este cuerpo?

Estas preguntas no las hace el dermatólogo en la consulta de 15 minutos. Tampoco las hace Google. Solo aparecen en el silencio.

Desde la neurociencia: el modo por defecto del cerebro, que se activa cuando no estamos haciendo nada, es el responsable de la autoconciencia, la integración emocional y la resolución de conflictos internos. No es tiempo perdido. Es el momento en que el cerebro se procesa a sí mismo.

6.3 · Las herramientas del silencio

No todo el mundo llega al silencio de la misma manera. Estas son algunas de las puertas de entrada que, combinadas con acompañamiento profesional, han mostrado evidencia en procesos de alopecia y enfermedades autoinmunes:

- **Meditación y mindfulness:** no para «relajarse», sino para entrenar la capacidad de observar sin reaccionar. El cuerpo que perdió el pelo ha estado en alerta. El silencio de la meditación le enseña a estar seguro.
- **Escritura terapéutica:** el método de James Pennebaker (Universidad de Texas) demostró que escribir sobre experiencias emocionalmente difíciles durante 15 a 20 minutos al día mejora los marcadores inmunológicos medibles. Escribir no es quejarse: es procesar.
- **Corporalidad y movimiento consciente:** yoga, danza, respiración somática. El cuerpo guarda lo que la mente no pudo integrar. Trabajar el cuerpo con conciencia es una forma de silencio activo.

- **La naturaleza como espejo:** salir a caminar sin audífonos ni teléfono. Observar. El contacto con la naturaleza reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés que puede desencadenar episodios de alopecia.

6.4 · Mi propio silencio

Hubo un momento, a los treinta y ocho años, en medio del segundo episodio, en que dejé de buscar. No porque hubiera encontrado la cura, sino porque algo se rompió de una manera diferente: ya no podía más con el propio ruido.

Empecé a hacer silencio. Primero con incomodidad. Con extrañeza. Luego con algo parecido a la paz. Y en ese silencio apareció una pregunta que cambió todo: ¿Qué parte de mí necesitaba que me parara? No era una pregunta médica. Era una pregunta de vida.

Busqué afuera durante años lo que estaba adentro todo el tiempo.



CAPÍTULO

07

Cuando perdemos algo, el pelo nos avisa

¿Qué estabas perdiendo cuando empezaste a perder el pelo? No siempre es obvio. A veces la pérdida es grande y visible: una separación, una muerte, un trabajo.

Pero a veces es silenciosa: una infancia que termina demasiado rápido, una madre que deja de estar presente de un modo que nadie nombra, una sensación de que el mundo ya no es tan seguro como antes. El pelo, ese gran delator, suele estar presente cuando algo importante nos pasa.

7.1 · El cuerpo como registro de lo que vivimos

La psiconeuroinmunología —la ciencia que estudia la relación entre emociones, el sistema nervioso y la inmunidad— lleva décadas documentando algo que intuitivamente muchas personas saben: el cuerpo guarda la historia que la mente no procesó.

El estrés, crónico o agudo, eleva los niveles de cortisol y de citoquinas inflamatorias. Estas moléculas pueden interrumpir el ciclo normal del folículo piloso, empujando los cabellos prematuramente a la fase de caída. En la alopecia areata, además, se activa una respuesta autoinmune: el sistema que debería protegernos ataca, por error, nuestros propios folículos pilosos.

7.2 · La teoría del apego: para entenderla sin ser psicólogo

Una nota especial para las madres y los padres que leen esto. En los años cincuenta, el psiquiatra británico John Bowlby propuso algo revolucionario para su época: los seres humanos nacemos con una necesidad biológica de vincularnos con otro ser humano que nos cuide. No es capricho. No es «malacrianza». Es supervivencia.

A ese vínculo se le llama apego. La figura de apego es la persona —generalmente la madre, el padre, o quien cumpla ese rol— a quien el niño busca cuando tiene miedo, cuando está enfermo, cuando el mundo se siente demasiado grande. Esa figura es, literalmente, la base de seguridad desde la cual el niño se atreve a explorar el mundo.

Cuando esa base es estable, cálida y predecible, el sistema nervioso del niño aprende: el mundo es seguro, puedo salir, puedo volver, estoy protegido. Cuando esa base falla —no porque los padres sean malas personas, sino porque son humanos con sus propias heridas— el sistema nervioso aprende algo distinto: no sé si habrá alguien cuando vuelva. Mejor me quedo alerta. Y un sistema nervioso en alerta permanente, con el tiempo, se enferma.

TIPO DE APEGO	CÓMO SE VIVIÓ EN LA INFANCIA	LO QUE EL CUERPO APRENDE	SEÑAL EN EL ADULTO
Seguro	Cuidador disponible, cálido, predecible	El mundo responde. Puedo confiar.	Resiliencia ante el estrés
Ansioso	Cuidador inconsistente	Debo estar alerta para no perder el vínculo	Hiperactivación, sistema inmune reactivo
Evitativo	Cuidador emocionalmente distante	No necesito a nadie. Me cuido solo.	Disociación del dolor físico
Desorganizado	Cuidador fuente de miedo o trauma	No hay salida segura	Mayor riesgo de enfermedades autoinmunes

7.3 · La primera pérdida: cuando el mundo deja de sentirse seguro

La primera pérdida no siempre es la muerte de alguien. A veces es:

- La llegada de un hermano que parece ocupar todo el espacio afectivo.
- Un divorcio de los padres que nadie explicó bien.
- Un cambio de colegio, de ciudad, de país.
- Una madre que entró en depresión y «apagó la luz».
- Un padre que estaba físicamente pero nunca emocionalmente.
- Una hospitalización infantil donde el niño se quedó solo.

Ninguna de estas cosas tiene que haber sido «dramática» para dejar huella. El sistema nervioso infantil no mide el drama. Mide la disponibilidad de la figura de apego.

7.4 · Una nota para madres y padres

Si estás leyendo esto porque tu hijo o tu hija perdió o está perdiendo el pelo, quiero decirte algo importante: no es tu culpa. El apego no consiste en ser perfectos. Se trata de ser suficientemente buenos, suficientemente presentes. Y casi todos los padres y madres están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen.

Pero sí te invito a hacer una pregunta: **¿Qué estaba viviendo mi hijo o mi hija antes de que empezara a caerle el pelo?**

No para culparte. Para ver. Para nombrar. Para acompañar de manera diferente. Porque muchas veces lo que el pelo pide no es una crema. Es una conversación. Es un abrazo que dure un poco más. Es que alguien diga: «Sé que algo te está pasando y aquí estoy».

|

La pérdida del pelo no siempre empieza en el cuero cabelludo. A veces empieza en una habitación donde un niño esperó a que alguien llegara, y llegó, pero no del todo.



CAPÍTULO

08

La mirada de los otros

Hay dos pérdidas de cabello. La primera es privada: la que vives frente al espejo, sola, en el baño, a las siete de la mañana. La segunda es pública: la que vives cuando sales a la calle y sientes que el mundo te mira distinto.

Esta segunda pérdida es la que casi nadie menciona en la consulta médica. Y es, muchas veces, la que más duele.

8.1 · El pelo como señal social

Desde las primeras civilizaciones, el cabello ha funcionado como un lenguaje no verbal cargado de significado. Los egipcios lo usaban para marcar jerarquía. Los griegos, para distinguir a los libres de los esclavos. En casi todas las culturas, cortar el pelo ha sido un símbolo de duelo, de castigo y de ruptura con el pasado.

El pelo es visible desde lejos, antes de que digamos una palabra. Comunica género, edad, salud, cuidado, pertenencia cultural. Es la primera capa del lenguaje corporal. Cuando ese lenguaje se interrumpe sin haberlo elegido, el cuerpo entra en un territorio nuevo e incómodo: la diferencia visible.

8.2 · La vergüenza y la mirada médica

Existe una forma particular de vergüenza que rara vez se menciona: la que generan ciertas interacciones dentro del sistema de salud. El dermatólogo que examina tu cuero cabelludo como si fuera solo una superficie, sin preguntarte cómo estás. El médico que dice «no te preocupes, es solo estrés», y minimiza tanto el síntoma como la emoción. El especialista que te muestra fotos de casos «peores que el tuyo» para que te sientas afortunada.

Estas interacciones, aunque no sean malintencionadas, refuerzan un mensaje: tu experiencia emocional no cuenta en este consultorio. Y ese mensaje tiene consecuencias clínicas medibles: menor adherencia a los tratamientos, mayor ansiedad y mayor probabilidad de abandono del proceso.

8.3 · Las preguntas que agotan

Hay preguntas que las personas con alopecia escuchan y que, con el tiempo, se vuelven casi físicamente dolorosas:

- «¿Qué te pasó en el pelo?»
- «¿Es una enfermedad grave?»
- «¿Te vas a quedar así?»
- «¿Has probado aceite de ricino, biotina o el tratamiento que vi en Instagram?»

La mayoría viene de buena intención. Pero lo que producen en quien las recibe es una obligación constante de explicarse, de justificar su cuerpo, de gestionar la incomodidad del otro mientras gestiona la propia. Eso tiene un nombre clínico: carga de estigma. Y es agotador.

8.4 · Mostrarse o esconderse: la decisión más pesada

Para muchas personas con alopecia, cada mañana implica una decisión que quienes tienen pelo nunca tienen que tomar: ¿me muestro como soy o me protejo? La peluca, el pañuelo, el sombrero: no son solo accesorios. Son estrategias de gestión de la exposición. A veces son armaduras. A veces son prisiones.

No hay una respuesta correcta. Lo que importa no es la decisión. Lo que importa es que sea tuya. Libre de culpa. Libre de la mirada de los demás.

*La mirada de los otros pesa. Pero hay algo que pesa más:
la mirada que te diriges a ti misma cuando nadie te ve. Esa
es la que decide todo lo demás.*



CAPÍTULO

09

Aceptación no es resignación

Durante mucho tiempo confundí aceptar con rendirse. Pensé que aceptar la alopecia era decir: «está bien, así soy, no me importa», y eso me parecía una mentira demasiado grande para sostener.

Me importaba. Claro que me importaba. Lo que no entendía entonces es que la verdadera aceptación no niega el dolor. Lo incluye. Lo honra. Y luego elige conscientemente no dejar que ese dolor sea el centro de gravedad de tu vida.

9.1 · Lo que la psicología dice sobre la aceptación

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) propone una idea que parece ir en contra de lo común: el sufrimiento no proviene del dolor, sino de luchar contra él. Cuando resistimos lo que sentimos y nos decimos «no debería sentir esto» o «ya debería haberlo superado», añadimos una capa de sufrimiento al dolor original.

Es el dolor del dolor de la alopecia: no se trata de fingir que no te afecta perder el pelo. Se trata de dejar de pelearte por el hecho de que te afecta y, desde ahí, elegir cómo quieres vivir con ello.

9.2 · Las etapas que nadie te cuenta

ETAPA	LO QUE APARECE
Negación	«Es temporal. Va a volver. No es tan grave.» Una protección necesaria al principio.
Rabia	«¿Por qué a mí? Mi cuerpo me traicionó.» Una emoción legítima que necesita expresarse.
Negociación	«Si pruebo este tratamiento... tal vez vuelva.» El intento de recuperar control.
Tristeza	La realidad aterriza. Oscuro, pero inicio de la integración real.
Integración	El dolor ya no define quién eres. La alopecia es parte de tu historia, no toda.

9.3 · El cuerpo no es el enemigo

Una de las consecuencias más silenciosas de la alopecia es romper la relación con el propio cuerpo. «El cuerpo que nos falló.» «El cuerpo que nos avergüenza.» Pero el cuerpo no es el enemigo. Es el mensajero.

La reconciliación con el propio cuerpo es un componente central del proceso de aceptación. No tiene que empezar con amor. Puede empezar con algo más pequeño y más honesto: la curiosidad. ¿Qué está intentando decirme este cuerpo? ¿Qué necesita que aún no le haya dado?

9.4 · Mi punto de inflexión

Hay un momento que recuerdo con mucha claridad. Fue alrededor de los treinta y cinco años. Llevaba ya varios años en el segundo episodio. Y un día, sin que nada externo cambiara, algo interno se asentó.

No fue un «ya no me importa». Fue más parecido a: me importa y está bien que me importe, y aun así voy a vivir mi vida completa. Eso fue la aceptación para mí. No hay una llegada. Un punto de inflexión desde el cual el camino empezó a verse distinto.

|

Aceptar no es rendirse. Es elegir, con plena conciencia del dolor, seguir siendo tú. Con pelo o sin él. Entera.



CAPÍTULO

10

De la herida a la comunidad

Hay personas que atraviesan el dolor y salen del otro lado queriendo olvidarlo. Y hay personas que salen del otro lado queriendo que nadie más lo atraviere por su cuenta.

Pelo a Pelo no nació de una idea de negocio. Nació de una pregunta muy simple: **¿qué habría necesitado yo que no existiera?**

10.1 · El vacío que nadie había llenado

Después de veinte años navegando la alopecia —como niña, como adulta, como psicóloga, como profesional de personas— llegué a una conclusión clara:

- El sistema de salud trata el síntoma.
- Las comunidades online contienen, pero no acompañan en profundidad.
- La familia quiere ayudar, pero no siempre sabe cómo.
- Los especialistas trabajan en silos y rara vez se comunican entre sí.

Y la persona con alopecia está en medio de ese vacío, tratando de armar el rompecabezas por sí sola. Pelo a Pelo nació para llenar ese espacio.

10.2 · El modelo de acompañamiento holístico

DIMENSIÓN	LO QUE NECESITA
Médica	Diagnóstico preciso, tratamiento informado, seguimiento real.
Psicológica	Espacio para el duelo, herramientas emocionales, trabajo de autoestima.
Social	Comunidad que entienda, reducción del aislamiento, narrativas compartidas.
Informativa	Educación honesta sobre la condición, opciones, pronósticos reales.
Existencial	Preguntas de sentido, conexión con el propio proceso de vida.

10.3 · La ciencia detrás de la comunidad

El aislamiento social activa en el cerebro las mismas zonas que el dolor físico. No es una metáfora, es neurociencia. Y lo contrario: la pertenencia y el ser visto y reconocido por otros que entienden desde adentro tienen efectos medibles en el sistema inmune, en los niveles de cortisol y en la calidad de vida.

Las comunidades de salud entre pares han demostrado en múltiples estudios reducir la ansiedad, mejorar la adherencia a tratamientos y aumentar la sensación de control sobre la propia condición. No porque den respuestas médicas. Sino porque hacen desaparecer la sensación de ser la única.

10.4 · La democratización del acompañamiento

Uno de los principios fundacionales de Pelo a Pelo es que el acompañamiento de calidad no puede ser un privilegio. En Chile y en gran parte de Latinoamérica, el acceso a psicólogos especializados en imagen corporal, a dermatólogos con tiempo real para sus pacientes, a comunidades informadas y seguras, es limitado y desigual.

La plataforma Pelo a Pelo quiere cambiar eso: ofrecer recursos accesibles, una comunidad amplia e información honesta y validada, sin importar dónde estés ni cuánto tengas. Porque la alopecia no pregunta por el código postal antes de llegar, y el acompañamiento tampoco

debería hacerlo.

Eso es Pelo a Pelo. Este libro no termina en un diagnóstico ni en una cura. Termina donde empieza lo importante: **en la decisión de no atravesar esto sola.**



EPÍLOGO

Lo que el pelo me enseñó

Hay preguntas que la vida hace con síntomas. El pelo fue, durante veinte años, la forma en que mi vida me preguntó: ¿quién eres cuando te quitan lo que crees que te define?

No tuve la respuesta enseguida. La fui construyendo despacio, con errores, con silencios, con recaídas, con acompañamiento, con trabajo interno que nadie ve desde afuera. Hoy, con la perspectiva de todo ese camino, puedo decirte lo que el pelo me enseñó:

- El cuerpo es más sabio que la mente.
- La belleza que más importa no se ve, se habita.
- Perder algo —ya sea el pelo, una relación o una versión de ti misma— no te vacía. Te deja espacio para algo más verdadero.
- La paciencia no es una virtud pasiva. Es una práctica diaria de confiar en tu propio proceso aunque no puedas ver el resultado.
- Nadie debería atravesar el dolor del cuerpo sin que alguien le pregunte cómo está por dentro.
- Que si este libro llegó a tus manos, probablemente no fue casualidad.



Bienvenida a Pelo a Pelo.

Aquí no estás sola.

— **Jessica Lagno Assael**

Santiago, Chile · peloapelo.cl